TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, Guarulhos - SP - CEP 07091-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1032206-28.2021.8.26.0224**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos**
Requerente:	**Estéfanie Pereira Santana Sobral**
Requerido:	**UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA**

Vistos.

I – RELATÓRIO

ESTÉFANIE PEREIRA SANTANA SOBRAL, ajuizou *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela e danos morais* em face de **UNIMED GUARULHOS.**

Narra, em síntese, que: (i) é beneficiária do seguro de saúde da ré desde 30/05/2020, sendo o plano de saúde de categoria empresarial; (ii) está gestante de 10 semanas; (iii) descobriu sofrer de trombofilia, com risco de interrupção da gestação e morte à parturiente e ao bebê; (iv) em razão da grave patologia, deve ser ministrada a solução injetável denominada ENOXOPARINA 40mg, uma vez ao dia, podendo ser encontrada pelo nome CLEXANE ou VERSA; (v) a ré negou o fornecimento alegando a inexistência de cobertura obrigatória por tratar-se de medicamento comercializado.

Assim, liminarmente, pugnou pela concessão de tutela de urgência para obrigar a ré a custear o tratamento indicado por seu médico. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência, bem como condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Tutela indeferida às fls. 50/54 e gratuidade de justiça concedida às fls. 66.

Notícia de antecipação de tutela recursal para conceder a tutela de urgência pleiteada pela parte autora (fls. 70).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 13/03/2022 às 18:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032206-28.2021.8.26.0224 e código KgMwPctB.

A ré apresentou contestação às fls. 74/82, sustentando, em síntese, que a cobertura de medicamentos fora do ambiente hospitalar é devida apenas nos casos de tratamento de câncer, o que não é a hipótese dos autos. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica às fls. 235/239.

Alegações finais às fls. 243/247 e 256/257.

Às fls. 262/271 foi colacionado aos autos o v. Acórdão dando provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito comporta julgamento antecipado, pois os fatos estão provados documentalmente, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou prova pericial, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.

As condições da ação devem ser aferidas in *status assertionis* e, no caso, foram demonstradas. As partes são legítimas e estão bem representadas. O interesse de agir foi comprovado, sendo a tutela jurisdicional necessária e a via escolhida adequada.

Superadas tais questões, passa-se ao mérito.

Com efeito, a autora pretende que a ré seja obrigada a custear medicamento prescrito por seu médico para tratar trombofilia, doença que coloca em risco a sua saúde, sua

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 13/03/2022 às 18:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032206-28.2021.8.26.0224 e código KgMwPctB.

gestação e a saúde do nascituro.

De início, curial salientar que é incontroverso o fato de o medicamento indicado pelo médico da autora ser, no caso analisado, de uso domiciliar.

Pois bem; conquanto se lamente a situação vivenciada pela parte autora e respeite entendimento contrário, não há possibilidade de condenar a ré ao custeio de tratamento por remédio de uso domiciliar, mesmo quando indicado por médico na hipótese apresentada nos autos.

Ressalta-se que a principal discussão não diz respeito à taxatividade do rol de cobertura da ANS, mas sim se o medicamento, de uso domiciliar, não antineoplásico e que não está sendo utilizado em *homecare*, é de cobertura obrigatória.

O art. 26, III, do Contrato de prestação de serviços médicos, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (fls. 204), especificamente em relação à discussão do caso em tela, está em consonância ao disposto no art. 10, VI, da Lei 9.656/98:

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12";*
>
> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *(...)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 13/03/2022 às 18:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032206-28.2021.8.26.0224 e código KgMwPctB.

II - quando incluir internação hospitalar:
(...)
g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar".

Art. 26. Estão excluídos da cobertura deste plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a segmentação assistencial contratada, ou sem a observância das diretrizes de utilização, bem como:

I – atendimentos prestados antes do início da vigência contratual ou do cumprimento dos prazos de carências, ou prestados em desacordo com o estabelecido neste contrato;
II – tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aqueles que:
a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;
b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina – CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia– CFO; ou
c) cujas indicações não constem da bula/manual registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (uso off-label);
III – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais constantes do rol de procedimentos definido pela ANS, e observadas as respectivas diretrizes de utilização;

Sobre o tema, toma-se a liberdade de transcrever esclarecedora decisão da Ilma. Ministra Nancy Andrighi ao analisar, recentemente, caso análogo:

"RECURSO ESPECIAL Nº 1894498 - SP (2020/0231637-0) DECISÃO. Cuida-se de recurso especial interposto por GABRIELA TACCO SALLES, fundado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP. Recurso especial interposto em: 09/06/2020. Concluso ao gabinete em: 23/09/2020. Ação: de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por GABRIELA TACCO SALLES em face de SOBAM - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, ***pretendendo a cobertura do medicamento Enoxaparina 40 mg, prescrito para o tratamento da doença que a acomete (trombofilia).*** *(...).* ***Assim, reconhecida a natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, passa-se a análise da questão relativa a obrigatoriedade de cobertura do medicamento pleiteado pela beneficiária, qual seja, Enoxaparina 40 mg****. Segundo informa o laboratório detentor do registro do Clexane (nome comercial da enoxaparina) na bula do paciente registrada na Anvisa, o medicamento é apresentado em "solução injetável de 20 mg/0,2 mL: embalagem com 2 e 10 seringas preenchidas com sistema de segurança; solução injetável 40 mg/0,4 mL: embalagem com 2, 6 e 10 seringas preenchidas com sistema de segurança; solução injetável 60 mg/0,6 mL: embalagem com 2 seringas preenchidas graduadas com sistema de segurança; solução injetável 80 mg/0,8 mL: embalagem com 2 seringas preenchidas graduadas com sistema de segurança; solução injetável 100 mg/1,0 mL: embalagem com 2 seringas preenchidas graduadas com sistema de segurança, para ser administrado por via subcutânea ou intravenosa, cuja via de administração varia de acordo com a indicação do produto". Além disso, verifica-se que a técnica de injeção intravenosa é indicada apenas para o tratamento de infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, o que não é a hipótese da recorrente (https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=CLEXANE , acesso em 11/08/2021). E, como registrou o TJ/SP, "não é possível entrever do relatório médico e a descrição do medicamento apresentada pela autora que se exige aplicação em ambiente*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 13/03/2022 às 18:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032206-28.2021.8.26.0224 e código KgMwPctB.

ambulatorial, ou equivalente (fls. 124 e seguintes)" , bem como "As seringas do medicamento são vendidas com a preparação habilitada para uso e providas de dispositivo de segurança automático sem nenhuma indicação de aplicação por profissional de saúde habilitado" (fl. 464, e-STJ). ***Trata-se, portanto, de medicamento para tratamento domiciliar a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, pois foi prescrito pelo médico assistente para ser autoadministrado pela paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado, tampouco se verifica ser a hipótese de o medicamento ser administrado em ambiente domiciliar em substituição ao atendimento ambulatorial ou hospitalar. Nessa toada, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.*** *Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021; e REsp 1.883.654/SP, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).* ***Logo, considerando que o fármaco requerido nos autos (Enoxaparina 40 mg) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998, forçoso concluir que não há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde****, como decidiu o TJ/SP. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e IV, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em seu favor de 15% sobre o valor da causa (fls. 358 e 465, e-STJ) para 18%. Previno as partes que a interposic?a?o de recurso contra esta decisa?o, se declarado manifestamente inadmissi?vel, protelato?rio ou improcedente, podera? acarretar a condenac?a?o a?s penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora* (STJ - REsp: 1894498 SP 2020/0231637-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 01/09/2021 − sem grifos no original).

Dessarte, considerando o exposto, a negativa de custeio por parte do plano é lícita, não podendo ser obrigado a custear o tratamento e, portanto, também não há de se falar em indenização por danos morais.

III − DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 13/03/2022 às 18:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032206-28.2021.8.26.0224 e código KgMwPctB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, Guarulhos - SP - CEP 07091-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Considerando que a tutela antecipada foi deferida pela Superior Instância, por cautela, fica mantida até decisão em contrário pela Segunda Instância ou trânsito em julgado da presente, o que ocorrer primeiro.

Em razão da sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade concedida.

De modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo, no importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou, caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da causa.

Oportunamente, nada sendo requerido pelos litigantes, com os registros devidos, independentemente de nova conclusão, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais, observadas as NSCGJ/SP.

Publiquem-se. Intimem-se

Guarulhos, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 13/03/2022 às 18:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032206-28.2021.8.26.0224 e código KgMwPctB.